EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 85396
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-28 08:53:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA EUGENIA BANDA BANDA			RUN	: 8.873.078-K
F.Nac	: 16-06-1959	Edad	: 64 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: ANDEQUIN 925 PB. ARAUCANIA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 995949731		
Fecha Ingreso	: 2024-05-21	Fecha Egreso	: 2024-05-28 08:53:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) SDRA severa resuelta
a) Neumonia multifocal 2° a influenza A
b) EPOC exacerbado
2) HTA
3) Dm2
4) EPOC
5) TBQ
6) Artrosis

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta por cuadro de CEG; tos y disnea a moderado esfuerzo de 3 dias de evolucion. COnsulta el 21/05; se describe a su ingreso HDN Estable, normocardico, polipneica, desaturando hasta 80%; , UMA (+), retraccion costal y supraclavicular (+), ex de lab al ingreso con PCR 88; Gb 14,1; influenza A (+),TAC de torax se evidencia vidrio esmerilado en lobulos superiores. SE incia terapia broncodilatadora + corticoesteroidal, con mejoria clinica significativa, destetando O2 suplemnatio hasta 36%, se decide traslado a UCI para CNAF.
Se incia terapia antivira y ATB, con mejora de respuesta clinica, se decide traslado a sala basica, con destete progresivo de O2 suplementario

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor, sin episodios de nauseas y/o vomitos, con buena tolerancia a alimentacion VO, desde hace 24 hrs sin apoyo con O2 suplementario, con buena respuesta.

Ex de lab -> crea 0,7; LDH 184; lactato 1,8; PCR 9,6; uremia 36; BUN 17, Na/K/Cl 137/3/99; GB 15,6; Hb/Hcto 12.9/38.3; plaq 370000; segment 61%; GSA pH 7,55; pO2 61,8, pCO2 30,3; HCO3 26.7

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
ABdomen Blando, distendido, RHA (+), sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Con parametros inflamatorios bajos, sin conflicto actual, se cultimaran 7 dias de terapia ATB total

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada asistida
2. Regimen diabetico hiposodico liviano a tolerancia
3. Omeprazol 20 mg al dia VO por 3 dias
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por un dia
5. Brexotide 2 puff c/12 hrs por AC por 3 dias
6. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC por 3 dias
7. Salbutamol 2 puff c/4 hrs por AC por 3 dias
8. Amlodipino 10 mg al dia VO
9. Losartan 50 mg c/!2 hrs VO
10. HIdroclorotiazida 50 mg al dia VO
11. Hidralazina 50 mg c/8hrs VO
12. Sertralina 50 mg, 2 -0-0 VO
13. Insulina NPH 16 UI AM - 8 UI PM SC
14. KNT respiratoria una vez al dia
15. Examenes de lab 30/05

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO